

CBE / EPA

Competency-Based Education / Entrustable Professional Activity

コンピテンシー基盤型教育と EPA -- 「点数」から「できること」へ

指導医・プログラムディレクター向け | 30 分 | 2026-03-24

導入の問い

USMLE（米国医師国家試験）で高得点の研修医が、
必ずしも「良い医師」になるとは限らない。
-- では、何で評価すればいいのか？

この 30 分の後、あなたは：

- CBE = Competency-Based Education（コンピテンシー基盤型教育）の基本概念を説明できる
- EPA = Entrustable Professional Activity（任せられる専門的活動）とマイルストーン評価を理解できる
- 自分の指導・研修に CBE の要素を 1 つ取り入れる計画を立てられる

試験の点数は何を予測するのか？

指標	事実	意味
USMLE Step 1 高得点	レジデントの臨床 パフォーマンスを予測しない	知識 ≠ 能力
クラークシップ 「優秀」評価	施設間で 5% ～ 67% のばらつき	基準が曖昧
筆記試験	「知っている」を測るが 「できる」を測らない	評価方法の不整合

「試験に受かる力」と「患者を診る力」は別物。
このギャップを埋めるのが CBE。

CBE（コンピテンシー基盤型教育）とは何か

	従来の教育	CBE
評価基準	時間（何年間研修したか）	能力（何ができるようになったか）
測定方法	筆記試験・口頭試験	EPA（実際の信頼レベル） + マイルストーン
指導者の役割	試験官・評価者	コーチ・伴走者
ゴール	合格ラインを越える	一人前の医師として任せられる

CBE = 「何年研修したか」ではなく「何ができるようになったか」で評価する仕組み

EPA -- 「任せられる」を段階的に評価する

EPA = Entrustable Professional Activity (任せられる専門的活動)

Level 1	観察のみ	見学している段階
----------------	-------------	----------

Level 2	直接指導下	指導医が横で見ている
----------------	--------------	------------

Level 3	間接指導下	一人でやって後で確認
----------------	--------------	------------

Level 4	自立実施	任せられる！
----------------	-------------	--------

Level 5	他者を指導	教える側になる
----------------	--------------	---------

「この研修医にこの行動を任せられるか？」が評価の核心

「評価者」から「コーチ」へ

	従来の指導医	CBE のコーチ
スタンス	「できなかったこと」を指摘	「できるようになったこと」を確認
フィードバック	年に 1-2 回の総括評価	日常的な短い対話
目的	合否判定	成長支援
関係性	上下関係	伴走・協働

「あの先生は厳しい」と言われる指導医から、
「あの先生がいると安心」と言われるコーチへ。

日本での動き

- 総合診療専門医制度（2017 年～）で EPA 的評価が導入され始めている
- 初期研修の「行動目標」が実質的な EPA に相当
- USMLE Step 1 の「Pass/Fail」化（2022 年）が全米で「点数から能力へ」の潮流を加速
- 日本の OSCE（客観的臨床能力試験）も「できる」を測る方向へ進化中
- 3/22 の AI 教育 RCT（保持率 91%）が示すように、AI が CBE を支援する時代が来ている

「点数で評価」から「任せられるかで評価」への転換は、日本でも始まっている

ディスカッション

4 分間 → 全体共有 2 分

あなたの研修現場で、
「点数では測れないが、医師として重要な能力」は何か？
それをどう評価すればいい？

明日からの 1 アクション

- 研修医の「できること」を 1 つ、EPA の Level で評価してみる
- 「できなかったこと」ではなく「できたこと」をフィードバックする
- 「次はこれを任せてみようか」という対話を、1 回してみる